DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

2ª Defensoria Pública da Comarca de Serra Alta

AO JUÍZO DA ___ª VARA DA COMARCA DE VILA BOA ESPERANÇA/MS

URGENTE. LIMINAR. PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO. PESSOA COM DEFICIÊNCIA

ROSA MARIA ANDRADE LEMES, brasileira, solteira, interditada, CPF nº 111.222.333-44, residente no Centro de Vila Boa Esperança/MS, representada por sua curadora, **CLARICE ANDRADE LEMES**, brasileira, casada, do lar, CPF nº 555.666.777-88, residente no mesmo endereço, por intermédio da DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL, propõe **AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA** em face do **MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA/MS** e do **ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL**, pelos fatos e fundamentos a seguir.

I. DA PRIORIDADE NA TRAMITAÇÃO

A requerente é pessoa com deficiência, com transtorno psiquiátrico crônico grave (CID 10: F20.0), conforme documentação médica anexa, e faz jus à prioridade do art. 9º, VII, da Lei nº 13.146/2015 e do art. 1.048, I, do CPC.

II. DOS FATOS

II.I. Do quadro clínico e da imprescindibilidade terapêutica

A requerente, com idade entre 60 e 65 anos, tem Esquizofrenia Paranoide (CID 10: F20.0), conforme laudo médico circunstanciado do Dr. Rodrigo Albuquerque Teles (CRM/MS 19876), do Centro de Atenção Psicossocial (CAPS) de Vila Boa Esperança/MS.

O quadro é grave: alucinações visuais e auditivas, irritabilidade e elevado risco de heteroagressividade. Pela cronicidade da doença, a autora está acamada e depende de terceiros para todas as atividades básicas da vida diária, conforme o questionário médico anexo.

Para controlar os sintomas psicóticos, a agitação psicomotora e a desorganização do pensamento, o médico prescreveu o uso contínuo de **RISPERIDONA 2 mg**, 01 (um) comprimido à noite. O laudo é categórico ao afirmar que a medicação é indispensável e insubstituível no momento, fundamental para a estabilidade clínica. A falta do fármaco traz risco iminente de descompensação psiquiátrica, agravamento do quadro e internação hospitalar, com perigo para a paciente e seus cuidadores.

II.II. Da tentativa de solução extrajudicial e da pretensão resistida

Diante da impossibilidade financeira de custear o tratamento, a Defensoria Pública buscou a via administrativa. Em 19/01/2026, encaminhou o Ofício nº 87/2026 à Secretaria Municipal de Saúde de Vila Boa Esperança/MS, pedindo o fornecimento urgente do fármaco, sem resposta efetiva do Município até a presente data.

Paralelamente, houve tentativa de conciliação no CEJUSC/TJ Saúde (Processo nº 0899571-87.2026.8.12.0098). O ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL respondeu negativamente, ao argumento de que a paciente não preenche os requisitos do Protocolo Clínico e Diretrizes Terapêuticas (PCDT) do Ministério da Saúde, embora reconheça que o medicamento está incorporado ao SUS e integra o Grupo 1B do Componente Especializado da Assistência Farmacêutica (CEAF).

A negativa é expressa na autorização estadual anexa, que registra "Não autorizado" para a Risperidona 2 mg porque a paciente já usa Quetiapina.

Ocorre que o médico assistente consignou que, embora a paciente utilize Quetiapina, a associação com a Risperidona é tecnicamente necessária e insubstituível para o caso concreto, não cabendo à Administração substituir a conduta de quem acompanha a paciente:

> "Diante do exposto, declaro que a medicação RISPERIDONA é imprescindível e insubstituível no momento para o tratamento da paciente, sendo fundamental para manutenção da estabilidade clínica. A ausência da medicação implica em grave risco à saúde da paciente, com possibilidade de descompensação significativa do quadro psiquiátrico." (trecho do laudo do CAPS)

III. DO DIREITO

A saúde é direito de todos e dever do Estado (arts. 6º e 196 da CF) e se liga à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) e ao mínimo existencial; a reserva do possível não pode ser oposta genericamente. A Lei nº 8.080/1990 consagra a integralidade da assistência (art. 7º, II).

Responsabilidade solidária (Tema 793 do STF). A obrigação é comum aos entes federados (art. 23, II, CF), de modo que Estado e Município são legitimados passivos. Regras internas de repartição, como a inclusão do fármaco no Grupo 1B do CEAF, não podem ser opostas ao cidadão.

Ilegalidade da negativa baseada no PCDT. É incontroverso que a RISPERIDONA 2 mg é medicamento incorporado ao SUS. Não se discute a eficácia do fármaco nem sua inclusão nas políticas públicas, mas um entrave burocrático de elegibilidade. O PCDT orienta a Administração, mas não é absoluto e não se sobrepõe ao laudo individualizado do médico do CAPS, que atestou a imprescindibilidade da medicação e a ineficácia de outras alternativas isoladas. Pela teoria dos motivos determinantes, a negativa ignora a realidade da paciente (risco de agressividade e internação).

O Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul tem precedentes que qualificam como formalidade excessiva a exigência de cadastro no PCDT diante de necessidade clínica demonstrada por laudo fundamentado. Assim, o laudo circunstanciado e o questionário médico suprem qualquer exigência protocolar, porque a medicina baseada em evidências aplicada ao caso pela equipe do CAPS demonstra que a Risperidona é a única alternativa eficaz para a estabilidade da autora.

Requisitos do Tema 106 do STJ. Ainda que se apliquem os requisitos do REsp 1.657.159, a procedência se impõe: (i) há laudo fundamentado atestando a imprescindibilidade; (ii) a incapacidade financeira é notória, pois a autora é assistida pela Defensoria Pública; (iii) o medicamento tem registro na ANVISA e é padronizado no SUS.

IV. DA TUTELA DE URGÊNCIA

Presentes os requisitos do art. 300 do CPC. A probabilidade do direito decorre da prescrição, do laudo e da admissão do Estado de que o medicamento é padronizado. O perigo de dano é grave: sem a Risperidona há risco de descompensação psicótica, auto e heteroagressividade e internação psiquiátrica evitável. Requer o fornecimento em 48 (quarenta e oito) horas.

V. DOS PEDIDOS

a) a gratuidade da justiça (art. 98 do CPC), dada a hipossuficiência da autora, assistida pela Defensoria Pública, conforme declaração anexa;
b) a tramitação prioritária;
c) a TUTELA DE URGÊNCIA, *inaudita altera parte*, para que o ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL e o MUNICÍPIO DE VILA BOA ESPERANÇA/MS forneçam imediatamente RISPERIDONA 2 mg, 01 comprimido à noite, de uso contínuo, em quantidade suficiente para o tratamento mensal, sob pena de multa diária;
d) em caso de descumprimento, o bloqueio de valores suficientes para a compra na rede privada;
e) a citação dos réus; f) a intimação do Ministério Público, diante da incapacidade civil da autora;
g) a confirmação da tutela e a procedência, com fornecimento regular e ininterrupto enquanto durar a necessidade clínica;
h) subsidiariamente, se o Juízo entender necessário, a consulta ao NATJus, sem prejuízo da liminar.

Provará o alegado pelos documentos já juntados: documentos pessoais, laudos médicos, declaração de hipossuficiência e ofício administrativo. Dá à causa o valor de R$ 1.621,00, para fins meramente fiscais.

Serra Alta/MS, 26 de fevereiro de 2026.

Patrícia Mendes Lacerda
Defensora Pública em substituição legal
(assinado digitalmente)